Canábis medicinal e cânhamo industrial: o que pode avançar já

Nota técnica para revisão externa · Novembro de 2026. Iniciativa independente de qualquer partido; começou em Janeiro de 2026 no contexto do LIVRE, de que o autor é militante. Bruno Camarneiro · documento completo, dados e fontes: camarneiro.com/cannabis-legalization · CC BY-SA 4.0

Em resumo. Portugal exporta canábis medicinal em grande escala, mas muito pouca chega aos doentes com apoio do Serviço Nacional de Saúde. O cânhamo industrial é uma cultura agrícola sujeita a autorização prévia. Esta nota propõe duas medidas que não dependem do debate sobre o uso recreativo: avaliar a aplicação da Lei n.º 33/2018 e rever o regime do cânhamo. A forma proposta é um projecto de resolução, com minuta pública, que recomenda ao Governo e não cria despesa por si.

1. Canábis medicinal: a prescrição sobe, a comparticipação desce

	2023	2024	2025
Exportação (kg) [1]	11.973	31.188	79.883
Embalagens prescritas em Portugal [1]	1.157	4.143	7.023
Embalagens comparticipadas pelo SNS [2]	289	236	159

As duas linhas de embalagens têm universos diferentes e não se dividem uma pela outra: a última conta só as farmácias comunitárias do continente e exclui o meio hospitalar.

- **A prescrição cresceu, a comparticipação desceu.** As embalagens prescritas multiplicaram-se por seis em dois anos. As comparticipadas caíram 45%. Das 159 de 2025, 146 são do extracto de THC e CBD, a substância do Sativex, que em 2021 somava 336 [2].
- **O acesso interno não ganhou peso.** A prescrição cresceu a um ritmo semelhante ao das exportações, e continuou em 2026: 5.413 embalagens e 66.305 kg só no 1.º semestre [1].
- **O doente paga quase tudo.** Uma caixa de 15 g de flor custava cerca de €150 em 2024 [3], e a flor só aparece comparticipada em 2025, em 7 embalagens [2].
- **A oferta aumentou.** Havia 16 preparações e substâncias com autorização de colocação no mercado em 2025, contra uma em 2023 [1].
- **Não se sabe quantos doentes há.** O Infarmed não publica esse número. Foi pedido ao abrigo da Lei n.º 26/2016 a 13 de Outubro; a resposta está pendente.

2. Cânhamo industrial: uma cultura agrícola com regime de excepção

- Só se trata de variedades com THC não superior a 0,3%, de semente certificada, elegíveis ao abrigo do direito da União Europeia [5].
- O cultivo exige autorização da DGAV, ao abrigo da Portaria n.º 83/2021, alterada em 2022 e 2023 [6]. Quando foi publicada, uma associação do sector, a CannaCasa, disse que estava a ser usada «como uma barreira» para os agricultores [7]. **Não medimos se o regime actual é desproporcionado.** É uma das perguntas desta revisão.
- Em França, 1.850 produtores cultivaram 24.600 hectares em 2024, segundo a interprofissão do sector [8]. Em Elvas, um ensaio de 2024 e 2025 avaliou quatro variedades nas condições do Alentejo [9].
- A área cultivada em Portugal foi pedida à DGAV a 13 de Outubro, sem resposta até à data desta nota.

3. O que se propõe

Recomendar ao Governo que:

1. avalie a aplicação da Lei n.º 33/2018 e do Decreto-Lei n.º 8/2019, identificando o que limita a prescrição e o acesso;
2. estude a comparticipação de medicamentos e preparações autorizados, indicação a indicação e com critérios de avaliação de tecnologias de saúde. A evidência não é igual para todas: há ensaios favoráveis na espasticidade da esclerose múltipla e em epilepsias raras (capítulo 4 do documento completo), e na dor neuropática uma revisão Cochrane de 2026 não encontrou prova clara de alívio com medicamentos dominantes em THC [4];
3. à luz dessa avaliação, simplifique o circuito de prescrição e dispensa onde ele se mostre uma barreira sem ganho de segurança, e reforce a formação dos profissionais de saúde;
4. avalie se o licenciamento do cânhamo é proporcional ao risco e, se não for, admita a mera comunicação prévia para fibra e semente de variedades certificadas, mantendo autorização para a flor e a extracção;
5. apresente à Assembleia da República os resultados no prazo de 180 dias.

Há precedente de consenso: em votação final global, a Lei n.º 33/2018 teve os votos a favor de PSD, PS, BE, PCP, PEV e PAN, e a abstenção do CDS-PP [10].

4. O que esta nota não afirma

- **Não afirma que comparticipar resolva o acesso.** O Canadá e o Reino Unido têm muitos doentes sem reembolso público, e a Alemanha retirou a flor do seguro público em Julho de 2026 [11]. Por isso se pede um estudo e não uma decisão.
- **Não tem um custo fiabilizado.** O documento completo trabalha com €5 a 12 milhões/ano para 5.000 doentes, mas esse número de doentes é um pressuposto, não um dado.
- **Não sabe o que são as 13 embalagens de CBD e de flor comparticipadas em 2025.** Só aparecem nesse ano, e a resposta do Infarmed não as identifica [2]. Em Março de 2025, o Observatório Português de Canábis Medicinal dizia que nenhuma preparação com autorização era comparticipada [12].
- **Não afirma que a canábis seja inócua.** Dependência, psicose e condução estão tratadas, com fontes, no capítulo 4 do documento completo.
- **Não trata do uso por adultos.** O documento completo propõe também, mais tarde e com votação própria, um regime para adultos. Esta nota não depende dele: se nunca avançar, estas medidas valem por si.

5. O que se pede a quem revê

Apoio, não. Pedem-se duas respostas: **alguma destas afirmações é falsa ou está desactualizada?** e **falta alguma fonte que devêssemos conhecer?** As correcções ficam públicas e datadas; o nome de quem as fez só aparece se o autorizar.

Fontes. [1] Infarmed, *Canábis Medicinal: Evolução da Atividade*, 2026, 1.º semestre. [2] Infarmed/SPMS, resposta de 19-10-2026 ao abrigo da Lei n.º 26/2016, ficheiro no repositório. [3] Euronews, 2024. [4] Ateş et al., *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2026, CD012182.pub3, doi:10.1002/14651858.CD012182.pub3. [5] Regulamento (UE) 2021/2115, art. 4.º, n.º 4. [6] DGAV, Cultivo de Cânhamo. [7] Lusa/Agroportal, 16-04-2021. [8] InterChanvre, 2024. [9] Saragoça et al., *Agronomy* 16(2), 2026. [10] Público, 15-06-2018. [11] KVN, 2026, sobre o §31(6) SGB V. [12] OPCM, 04-03-2025. Referências completas na bibliografia do documento.